

במדינות שבהן יש מערכות פרטיות למטרת רווח, אלו בדרך כלל מערכות יעילות מבחינה תפקודית אולם מחיר השירות גבוה. כדי למנוע את השחיקה המקצועית של השירות הניתן על ידי ארגונים פרטיים נדרשות אמות מידה ציבוריות המפוקחות על ידי הממשלה.

שירות הניתן על ידי ארגוני מתנדבים, דוגמת הצלב האדום, חייב להיות ברמה מקצועית גבוהה לא פחות מהשירות הניתן על ידי הארגונים הממשלתיים. היתרון היחסי של שירות שכזה הוא המחיר הנמוך שנדרש הלקוח לשלם עבור השירות. חיסרון אפשרי של שירות התנדבותי הוא שלא יהיו לו די משאבים לתת את השירות במלואו. התבססות על מתנדבים בלבד יכולה לפגום בזמינות הצוותים בשעות מסוימות ביממה ובתקופות שונות בשנה. במקומות רבים בעולם יש מגוון ארגונים ובהם, לצד שירות פרטי או ציבורי המופעל על ידי בית החולים ושירותי חירום עירוניים או ממשלתיים, יש גם ארגוני רפואת חירום התנדבותיים שעיקר הטיפול שהם נותנים הוא העברת מטופלים בין בתי חולים ומוכנות לשעת חירום.

מגן דוד אדום - ארגון רפואת החירום הטרומ־אשפוזית של ישראל

מגן דוד אדום (מד"א) הוא הארגון הלאומי להצלה ולשירותי דם של ישראל. הוא מוגדר כארגון חירום טרומ־אשפוזי. על פי חוק מגן דוד אדום, תשי"ז-1950, מד"א הוא אגודה ארצית שתפקידה בישראל הוא מתן שירותי עזרה ראשונה, התרמה ואגירת דם, והיא ממלאת בישראל את תפקידי אגודת הצלב האדום על פי אמנת ז'נבה. הארגון חרט על דגלו את האמרה התלמודית: "כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא" שהגדירה את ייעודו המרכזי מיום היווסדו ועד היום: הצלת חיי אדם באמצעות רוח התנדבות ומחויבות של אלפי מתנדבים ועובדים הרואים בהגשמת הייעוד ערך נעלה ומשקיעים מעל ומעבר להגשמתו.



תמונה 1.1 לוגו של מגן דוד אדום:
ארגון ההצלה של מדינת ישראל

מגן דוד אדום הוא חלק מההיסטוריה של מדינת ישראל והוא חלק בלתי נפרד מן ההווה הישראלית. זה 90 שנה משרת מד"א בנאמנות את תושבי מדינת ישראל בשגרה ובעיתות חירום לאומיות בכל הנושאים העיקריים הנובעים מהערך הנעלה של קיום נפש בישראל: הגשת עזרה ראשונה ורפואת חירום טרומ־אשפוזית, הן בסיסית והן מתקדמת, הנחלת הידע בתחום זה לציבור הרחב ולמערכת הרפואה באמצעות קורסים, הדרכות והכשרות מקצועיות, התרמת דם ואספקתו לבתי החולים ופעילות הומניטרית למען נזקקים.

בכל 38 שניות בממוצע מוזנק צוות מד"א לאירוע חירום, החל מהתקף לב או תאונת דרכים ועד לילודת בתהליך לידה. מתחנה קטנה בתל אביב ובה אמבולנס יחיד, הפך מד"א לארגון ראשון במעלה בעולם בתחום רפואת החירום ולו 180 תחנות הזנקה בכל רחבי הארץ, כ־1,200 אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, מסוקים, סירות ואופנועים לטיפול חירום המאוישים בצוותים מקצועיים שמגישים טיפול חירום רפואי לכל תושבי המדינה ללא הבדלי דת, גזע מין ולאום. למד"א מגיעות כ־800,000 קריאות בשנה בממוצע והוא אוסף כ־265,000 מנות דם בשנה באמצעות בנק הדם הלאומי.

מתנדבים הם שהקימו את מד"א והיו פעילים בו מראשיתו. כיום מונה מערך המתנדבים מעל 40,000 אנשי צוות ובהם: חובשים, פראמדיקים, רופאים, מתנדבי נוער ונאמני חיים. נאמני חיים הם כונני תגובה שיש ברכבם הפרטי

ציוד עזרה ראשונה והחייאה והם מטפלים בנפגעים עד להגעת צוותי האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ.

להגשמת ייעודו של מד"א שותפים כל אזרחי ישראל וגם תורמים ומתנדבים רבים מרחבי העולם. הארגון שואף לשתף בהגשמת ייעודו את כל מי שמוכן לסייע בכך. השותפים החשובים ביותר הם אלו שזיהו אירוע חירום רפואי והתקשרו למוקד החירום, מי שעברו הכשרה בהחייאה בעזרה ראשונה, אנשים שהצטרפו לקבוצת "נאמני החיים" - אזרחים בעלי הכשרה רפואית שמוזנקים לאירועי חירום לפי קרבתם למקום האירוע, אלו שהורידו את היישומון (האפליקציה) שתכננה מד"א המאפשרת לסייע בעת חירום, כל אדם שתורם דם או מוצרי דם (למשל פלזמה, טסיות), מי שתורם מזון לנזקקים, כל אדם שתורם מכספו וכל מי שרוחו קוראת לו להתנדב לשירות הארגון להצלת חיים בישראל.

מד"א מספק שירות רפואת חירום טרום-אשפוזית המשלב את הדגם ה"צרפתי-גרמני" והדגם ה"אנגלי-אמריקאי" לפי אופי האירוע ומצבו של המטופל. אומנם בבתי החולים בישראל מתאפיינים במחלקות רפואת החירום מבוססות היטב: מחלקות טיפול נמרץ ומחלקות טראומה, אך על פי פרוטוקולים הקבועים מראש ולפי שיקול דעתם הרפואי של אנשי הצוות יש מקרים שבהם רוב הטיפול ניתן בזירת האירוע טרם הפינוי לבית החולים.

מימון מגן דוד אדום

שלא כמו בתפיסה הרווחת, מד"א אינו ארגון ממשלתי ואינו ממומן כמעט כלל על ידי משלם המיסים, על אף תפקידו כארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל. בהיותו גוף הפועל על פי דין, לא ממשלתי וללא מטרות רווח מיום הקמתו, מד"א מסתמך על סיוען ותמיכתן של אגודות הידידים והתורמים בישראל וברחבי העולם. מד"א הוא ארגון של העם ולמען העם. מקורות המשאבים שלו מגיעים ממכירת שירותים (60%), מתרומות והתנדבות (30%) וממימון ממשלתי (10%) שעיקרו קניית שירותי רפואת חירום על ידי המדינה.

צעדים ראשונים

כמעט באותו זמן שהוקם "מגן דוד אדום" בניו יורק בשנת 1918, הוקם ביפו, בספטמבר 1918, על פי הצעת ועד המתנדבות של "הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל" גוף שנועד לפעול כארגון התנדבותי שישירתו בו רופאים, אחיות, חובשים ובעלי תפקידים אחרים, ומטרתו להגיש סיוע רפואי וסיעודי לחיילי הגדודים העבריים וכן לאוכלוסייה במקרה של אסון גדול.

עם הקמתו פרסם הארגון קול קורא לצעירי ישראל להתגייס לשורותיו בשל הערך הלאומי שהוא מייצג. בקריאתם אמרו המייסדים בין השאר: "לא על בני עם נוכרי, המדברים שפה נוכריה, צריכים אנו להטיל את הטיפול בגיבורי חיילינו בזמן שתקף אותם מחלה או פציעה בשדה הקרב. לא בשם סמל זר ותחת דגל קדושה נוכריה יטיפו ננחומים לחיילינו השוכבים על ערש דוויו".



תמונה 1.2 תרגול של קורס חובשים מתנדבים, 1932

הקריאה נפלה על אוזניים קשובות: כ־500 איש התנדבו לארגון עם הקמתו, וחמש מתנדבות צעירות נשלחו לטפל בפצועי הגדודים העבריים,

בבית החולים הצבאי הבריטי שפעל בדיר־אל־בלח, ליד עזה. שני הארגונים האלה חדלו להתקיים עם פירוק הגדודים העבריים בשנת 1921, ותשע שנים עברו עד ש"מגן דוד אדום" הוקם מחדש בתל־אביב, לנוכח צורכי אוכלוסייתה הגדלה והולכת ללא הרף.

הלחץ להקמת גוף שיגיש עזרה ראשונה גבר והלך לנוכח העובדה שהפעילות התוססת בעיר - פעילות



תמונה 1.3 צי האמבולנסים של מד"א בירושלים
בשנות ה־50

כלכלית־תעשייתית־תחבורתית ופעילות חברתית - הביאה עימה גם גידול במספר התאונות. ב־7 ביוני 1930 התכנסו בבית קפה על שפת ימה של תל אביב שבעה אנשי מעשה - ד"ר משולם ליבונטין, חיים אלפרין, משה רבינוביץ, משה פרנקל וד"ר ישעיהו ליבוביץ - כדי לדון בנושא. ב־במקום החליטו כולם להקים אגודה לעזרה מהירה ושמה "מגן דוד אדום - תל־אביב" וד"ר ליבונטין נבחר ליו"ר האגודה. חודש אחד לאחר מכן נפתח הקורס הראשון לעזרה ראשונה, ובו השתתפו 73 מחברי גדוד המתנדבים הראשון של האגודה. עם אישורה של האגודה ב־1930 היא החלה לפעול לגיוס כספים מקרב הציבור, והציבור נרתם למשימה. גדוד המתנדבים הלך וגדל ופעילות האגודה גדלה אף יותר. למטרות הארגון נוספה מטרות חשובה: לעסוק בהדרכת הציבור הרחב בנושאי עזרה ראשונה, במניעת מחלות ובהיגיינה.

בדצמבר 1935 הושלמה בנייתו של הבניין הראשון של "מגן דוד אדום" בארץ ישראל ובעולם כולו ברחוב מזא"ה בתל אביב. התחנה שימשה את הציבור התל־אביבי באמונה עד 1976, ואז הועברה פעילותה לבניין חדש ברחוב השל"ה בתל־אביב. הבניין ברחוב מזא"ה המשיך לשמש כתחנת הזנקה לאמבולנסים עד החזרתו לרשות עיריית תל־אביב ביולי 2014.

שירותי העזרה הראשונה של תל־אביב נקראו לא אחת לסייע מחוץ לעיר. הדבר הדגיש את הצורך להקים סניפים של האגודה במרכזי אוכלוסייה יהודיים אחרים בארץ. ואכן, בסוף 1932 הוקם סניף מד"א בירושלים ובאוגוסט 1933 נוסד סניף מד"א בחיפה.

מאורעות 1936 ("המרד הערבי הגדול") הגבירו את הצורך בעירוי דם להצלת חייהם של נפגעים. ד"ר ליבונטין הגה אז את הרעיון להקים בנק דם - אגודה מיוחדת של מתנדבים שיאספו דם מתורמים וימסרו אותו לבתי החולים בעת הצורך.

הבסיס החוקי לפעילות מגן דוד אדום בישראל

עם הקמת המדינה נפתח פרק חדש בפעילות מד"א כשהמדינה הצעירה הכירה בו כארגון ההצלה הלאומי. במהלך הקרבות ולאחריהם זכה מגן דוד אדום לשבחים רבים, ולאיש לא היה ספק בדבר הצורך החיוני של המדינה הצעירה בשירותי האגודה. ואכן, כבר בשנת 1950 נתקבע מעמדו הייחודי של מד"א, כשהכנסת קיבלה

את חוק "מגן דוד אדום" המכיר רשמית באגודה כארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, שהוא המקבילה הישראלית לארגון "הצלב האדום" בעולם ופועל על פי אמנת ז'נבה. החוק הישראלי החדש קבע כי מד"א ימלא תפקידים של אגודה ארצית, יפעל כשירות עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בזמן מלחמה ולהג"א בעת הצורך, ועליו להתכונן למשימה זאת בעת שלום. מד"א יקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה ושירותי אשפוז ארעי לשעת דחק. מד"א יקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלזמה ומוצרי לוואי שלהם. כן ימלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה.

החוק מוסר את ניהול הארגון למד"א עצמו וקובע שהנהלת הארגון ומועצתו יהיו האחראיות הבלעדיות לענייניו, ובידו הרשות להכניס שינויים בתקנון. למד"א ניתנה השליטה הבלעדית גם על הרחבת פעילות הארגון וקביעת המקומות שבהם יוקמו סניפים של מד"א.

החוק קובע עוד כי למד"א מוקנית בלעדיות על השירות ואומר כי "האגודה והיא בלבד תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית" - תפקידים שנועדו על פי אמנת ז'נבה לאגודות ארציות של "הצלב האדום" או לאגודות עזרה ראשונה של מתנדבים, המוכרות והמוסמכות לכך על ידי ממשלותיהם. בשנות ה-80 קמו בישראל עוד ארגוני הצלה, ארגונים המבוססים על מתנדבים ומגיבים ראשונים, אך על פי חוק הכנסת, "האגודה והיא בלבד תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית".

עם השנים הורחבו בחוק מטרות אלו ובתקנון מד"א הנוכחי, שאושר סופית ב-1998, נוספו לארגון עוד יעדים: הדרכה בתחום העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם אשפוז, קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי (BLS) ומתקדם (ALS), קיום מערך של ניידות לטיפול נמרץ, הסעת חולים וילדות, פינוי נפגעי תאונות ופינוי הרוגים ונפגעים, וכמו כן הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים למקומות שבהם הם נדרשים בדחיפות.

חוק מד"א שנתקבל בכנסת, קבע שנשיא האגודה ימונה לתפקידו על ידי נשיא המדינה. בדרך זאת הגיעו לעמדה מכובדת זו כמה מבכירי הרופאים בישראל, כגון פרופסור אריה הראל, שהיה שגריר הראשון של ישראל בברית המועצות ולאחר שובו נתמנה לנשיא מד"א. נשיא מד"א כיום הוא מי שהיה קצין חינוך ראשי בצה"ל, אלוף (מיל) אבי זוהר, שלפני תפקידו הנוכחי היה מנכ"ל מד"א.

ארגון מגן דוד אדום

מד"א מאורגן בשמונה מרחבים גאוגרפיים. חלוקה זו מבוססת על החלוקה המקורית (11 מרחבים) שנקבעה על פי פיזור בתי החולים ותחנות מד"א בארץ. בכל מרחב יש מוקד מרחבי שנמצא בתחנה הראשית וכן נקודות הזנקה לאמבולנסים ברחבי המרחב. המרחבים פועלים בסיוע הדדי, כך שאם במרחב אחד יש עומס והוא זקוק לאמבולנסים נוספים, ישוגרו אמבולנסים מהמרחבים השכנים דרך מערכת השליטה והבקרה של מד"א. מערכת זו מאתרת את האמבולנס הזמין הקרוב ביותר ללא קשר לשיוכו המרחבי.

ביישובים מרוחקים שלא קרובים לבתי חולים מאוישים אמבולנסים שנמצאים ביישוב. האמבולנסים מתופעלים על ידי מתנדבים שגרים באותו יישוב. האמבולנסים השייכים למד"א ומתופעלים על ידי צוותי מד"א משרתים רק את היישוב שבו הם נמצאים.

אנשי מגן דוד אדום

אנשי הצוות של מד"א הם מתנדבים ועובדים שקיבלו הכשרה מקצועית ממחלקת ההדרכה של מגן דוד אדום ומבית הספר לפראמדיקים. מד"א מכשיר כל העת מגישי עזרה ראשונה, חובשי רפואת חירום, חובשים בכירים ופראמדיקים.



תמונה 1.4 אנשי מד"א

ארגון "נוער מד"א" מפעיל כ-11,000 בני נוער מתנדבים (בני 15 ומעלה) שהוכשרו כמגישי עזרה ראשונה (מע"רים). בני נוער אלו הוכשרו בקורס של 60 שעות שאותו מעבירים מתנדבי נוער בוגרי קורס מדריכים. מתנדבי הנוער עוסקים גם בפעילויות חינוך ומנהיגות, בפעילות הומניטרית, בפעילות רפואית על האמבולנסים, וכן מעבירים הדרכות עזרה ראשונה בארגון נוער מד"א ובקהילה.



תמונה 1.5 נוער מד"א

נוסף עליהם יש בארגון כ-11,000 מתנדבים בוגרים קבועים שהוכשרו ברמות הכשרה שונות, החל מחובשי רפואת חירום וחובשים בכירים דרך פראמדיקים ועד רופאים וכן עוד כ-17,000 מתנדבי "אד-הוק", אלו מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתכלית זו, והם מוזנקים למקרים דחופים בקרבת מקום מגוריהם.



תמונה 1.6 חובש

חובשי רפואת חירום עוברים קורס של 243 שעות לימוד הכולל פרקים בהיכיה, במצבי חירום רפואיים, בטרומה, במצבי חירום של מחלות לב (מצבים לבביים), בטיפול בנפגעים, בטיפול באוכלוסיות מיוחדות, בגינקולוגיה, בפדיאטריה, וכן הם עוברים התנסות מעשית באמבולנסים ולומדים פרק הקשור בנהיגת אמבולנס. החובשים משמשים בתפקיד נהגי אמבולנס וראשי צוותים באמבולנס רגיל.

החובשים הבכירים עוברים קורס של 200 שעות, הכולל אנטומיה של מערכות הגוף, פרמקולוגיה ותרופות, ההיכיה, לקיחת אנמנזה ובדיקה גופנית, טיפול במצבי חירום רפואיים, מצבי חירום נשימתיים, קרדיולוגיה, טרומה, פגיעות בטן, גינקולוגיה ופדיאטריה, וכן הם עוברים התנסות מעשית בניידת טיפול נמרץ. עם סיום הקורס ממלאים החובשים הבכירים תפקיד של נהגי הניידות לטיפול נמרץ.

החובשים והחובשים הבכירים הם ליבת אנשי הצוות הרפואי במד"א והם ממלאים מגוון תפקידים: נהגי אמבולנס, מלווים באמבולנסים ובניידות לטיפול נמרץ, מוקדנים וכוני תגובה מיידית. הפראמדיקים של מגן דוד אדום הם חוד החנית של רפואת החירום בישראל. הפראמדיקים משמשים בתפקיד ראשי צוותים בניידות לטיפול נמרץ ומעניקים טיפול מתקדם במסגרת טרום-בית החולים, בדרך כלל במצבים מסכני חיים. הם מטפלים סמוך לרגע

התפרצות המחלה או מייד לאחר שקרתה הפציעה. הטיפול שנותנים פראמדיקים כולל הערכה ראשונית של המטופל או הנפגע, אבחון ומתן הטיפול הרפואי לפי הצורך: במתן תרופות, החדרת נזלים או ביצוע פרוצדורות מצילות חיים כדי לטפל במצב הרפואי המסוים. בדרך כלל הטיפול ניתן בזירת האירוע או תוך כדי פינוי לבית החולים, שם יקבל המטופל טיפול משלים וייעודי. הפראמדיקים מגיעים למטופל עצמו באמצעות ניידות טיפול נמרץ, אופנועים, סירות ודרכי גישה מהירה אחרות כמו מסוק או יחידת חילוץ, לפי הצורך.

קורס הפראמדיקים מורכב משלושה שלבים. בשלב ראשון נלמד החלק העיוני הכולל אנטומיה, פיזיולוגיה,



תמונה 1.7 פראמדיקים

פרמקולוגיה, לקיחת אנמנזה ובדיקה פיזיקלית, ניהול נתיב אוויר, מחלות נשימה, קרדיולוגיה, מצבי חירום בילדים, טראומה, מיידות וגניקולוגיה, ניהול אירועים רבי-נפגעים (ארץ) ועוד. השלב השני הוא שלב מעשי שבו התלמידים עושים סבבים קליניים בבתי חולים במשך עשרה שבועות. המחלקות שבהן נעשים סבבי ההכשרה הן: מחלקות רפואה דחופה, חדרי ניתוח, מחלקות טיפול נמרץ, חדרי לידה ועוד. בשלב השלישי הפראמדיקים לעתיד מתנסים בניידות טיפול נמרץ בתחנות מד"א ברחבי הארץ.

מחלקת ההדרכה של מגן דוד אדום

מחלקת ההדרכה של מד"א קיימת מיום היווסדו של הארגון, שאז אנשי מד"א הדריכו את אנשי ארגון ההגנה בהגשת עזרה ראשונה. כיום המחלקה מעבירה קורסים ברמות שונות, החל בקורסי החייאה בסיסית לציבור הרחב, קורסי עזרה ראשונה לחברות ולקבוצות ועד לקורסי ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) לצוותים רפואיים מתקדמים. עם זאת, מטרתה העיקרית של מחלקת ההדרכה היא להכשיר ולהסמיך את אנשי הצוות של מגן דוד אדום. מחלקת ההדרכה של מד"א היא מרכז הכשרה רשמי של איגוד הלב האמריקאי (American Heart Association: AHA).



תמונה 1.8 קורס עזרה ראשונה לקהל הרחב

בית הספר לפראמדיקים של מגן דוד אדום מכשיר את רוב הפראמדיקים במדינת ישראל. פראמדיקים אחרים מוכשרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשיתוף פעולה עם מד"א. כמו כן, בית הספר לפראמדיקים מכשיר את הפראמדיקים הצבאיים בשיתוף פעולה עם צה"ל.

נוסף על כך, במסגרת פעילות ההדרכה מד"א מפעיל מכללה בין-לאומית להדרכת עזרה ראשונה ולהקמת מערך רפואה דחופה במדינות מתפתחות, וכן עוסק בהכשרה והנחיה של ארגוני צלב אדום ברחבי העולם, הדרכה בקהילות יהודיות ברחבי העולם והכשרת גופים מקצועיים בתחום רפואת החירום. מגן דוד אדום מדרך כמאה אלף איש מדי שנה.

מנהלי מגן דוד אדום

המנהל הכללי של מגן דוד אדום עונה לאות הקריאה מד"א 1, משנה למנכ"ל עונה לאות קריאה מד"א 2 וסגני מחולקים לפי זרועות הארגון שהם מנהלים: רפואה, מבצעים, קהילה, ארגון ופיתוח, כספים, תפעול ושירותי הדם.

תחת הנהלת מד"א נמצאים מנהלי המרחבים העונים לאות קריאה לפי שם המרחב + 1 (לדוגמה - איילון 1, לכיש 1) סגנים ובעלי תפקידים נוספים מקבלים אות קריאה 2-9. וכן יש קודים המשמשים לחירום כגון: פיקוד 10, רפואה 10, פינוי 10 וחניון 10 שפועלים באירועים רבי-נפגעים (על כך ראו בפרק 26).

מענה ממוקד מד"א

מוקד מד"א מוכר לציבור הרחב ככתובת הראשונה שאליה פונים בזמן חירום ומצוקה, על ידי חיוג טלפון 101 - מספר שהוא מטבע לשון שמשמעותו הצלת חיים. בעבר פעלו מוקדי מד"א בכל תחנה ותחנה, כיום בזכות ההתפתחות הטכנולוגית פועלים מוקדים מרחביים, שבהם מעניקים חובשים ואנשי רפואה מיומנים מענה לכל הקריאות מהמרחב וגם הנחיות רפואיות לדוגמה בהחייאה או בלידה. כבר בשנת 2004 הופעלה במד"א מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת המבוססת על הזרמת מידע בזמן אמת. כמו בשאר מערכות השליטה והבקרה



תמונה 1.9 מוקד מד"א - המוקד הארצי בקריית אונו

במד"א, גם מערכת זו היא פרי פיתוח עצמי, והיא פותחה ושוכללה כדי להתאים לצרכיו הייחודיים של הארגון. המערכת שודרגה מאוד בשנת 2007, עם הקמת המוקד הלאומי המשולב (הממל"מ) של מד"א בקריית אונו. כיום זהו מוקד מרכזי, משוכלל ומתקדם, המעניק גיבוי אנושי וטכנולוגי למוקדים המרחביים. המוקדנים של מד"א הם מוקדנים מקצועיים שעברו הכשרות רפואיות שונות: החל בחובשי רפואת חירום ועד פראמדיקים. אלו עוברים הכשרה נוספת כמוקדנים והם לומדים איך לבצע תשאול טלפוני, להעביר הוראות למתן עזרה ראשונה והחייאה דרך הטלפון ולנהל אירועים רבי-נפגעים ואסונות.

במוקד הלאומי המשולב של מד"א נמצא גם המוקד הרפואי, המאויש על ידי פראמדיק בכיר ורופא. המוקד הרפואי מפקח על עבודתם המקצועית של הצוותים הרפואיים ונותן ייעוץ רפואי בזמן אמת לאנשי הצוות בשטח. כמו כן יש מוקד כוננים שבאחריותו להזניק ללא דיחוי כונני תגובה לאירועים וכן מוקד בתי ספר שמספק שירותי רפואה שאינם דחופים לתלמידי מערכת החינוך בישראל.

רמות התגובה של מגן דוד אדום

למד"א ארבעה נדבכי הפעלה:

- (1) **מוקד החירום הטלפוני 101** - עונה תוך 3.8 שניות במומוצע לכל קריאה. במהלך השיחה למוקד החירום המוקדנים המקצועיים נותנים למתקשר הוראות לביצוע פעולות עזרה ראשונה והחייאה בסיסית עד שיגיע הצוות הרפואי המיומן של מד"א. למוקד זה תפקיד חיוני בהצלת חיים.

- (2) **נאמני חיים** - אלו אזרחים שקיבלו הכשרה רפואית ואינם אנשי צוות במד"א. הם מתנדבים אד-הוק, כלומר הוכשרו במיוחד לתפקיד זה. המתנדבים נרשמים דרך יישומון ייעודי ומוזנקים במקרים קשים שבהם ביכולתם לסייע לנפגעים עד שמגיעים צוותי מד"א. גם להם, כמו לעוברי האורח שמתקשרים למוקד 101, תפקיד חיוני ברגעים הקריטיים של הצלת חיים.
- (3) **מערך התגובה המיידית** - 6,500 חובשים ופראמדיקים מתנדבים שברשותם ציוד עזרה ראשונה והחייאה. יש כוננים שמחזיקים ציוד בכלי הרכב האישי שלהם, וכן יש כוננים הרכובים על אופנועים, אופניים ועוד כלי רכב קטנים בעלי עבירות גבוהה של מד"א שמגיעים לזירת האירוע תוך 4.6 דקות בממוצע.
- (4) **אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ** - מגיעים לזירת האירוע תוך 8 דקות בממוצע.

כלי הרכב בשירות מגן דוד אדום



תמונה 1.10 אמבולנס מד"א



תמונה 1.11 ניידת לטיפול נמרץ

במציאות שבה בכל 38 שניות מוזנק צוות של מד"א לטפל באירוע חירום, יש צורך להגביר את הזמינות ולהיות קרובים ככל האפשר למבקשי השירות כדי לשפר באופן ניכר את סיכויי ההחלמה והשרידות שלהם. ייעודו של מד"א הוא לתת טיפול רפואי מקצועי ופינוי מהיר בהשגחה בזמן הקצר ביותר, ולכן כלי התחבורה במד"א הם חלק חשוב ומהותי בארגון. יש לארגון כלי רכב מסוגים רבים: אמבולנסים, ניידות לטיפול נמרץ, אופנועים, מסוקים וסירות.

האמבולנסים - מופעלים על ידי חובשי רפואת חירום וחובשים בכירים בשילוב מתנדבי נוער בני 15 ומעלה. הם מצוידים באמצעים לספק סעד חיים בסיסי וחצי-מתקדם הכולל: ציוד החייאה, דפברילטור חצי-אוטומטי, חמצן, עירוי נוזלים, אפיפן, אספירין, ציוד חבישה וציוד עזרה ראשונה. במקרי פציעה או מחלה קשים הוא מסוגל לתת מענה ראשוני, לפני הגעת ניידת טיפול נמרץ. אפשר לפנות בו שני מטופלים שוכבים או מטופל שוכב אחד ושלושה מטופלים יושבים.

ניידות לטיפול נמרץ (נט"ן) - מוזנקות למקרי חירום קשים יותר ומופעלות על ידי פראמדיקים שמשמשים בתפקיד ראשי צוות, ולצידם חובשים בכירים בתפקיד נהגי האמבולנס והמלווים, וכן חובשים ומתנדבי נוער שעברו הכשרה מתאימה לנט"ן. הניידות לטיפול נמרץ מצוידות בציוד המאפשר לתת סעד חיים מתקדם (ALS) וכולל: מוניטור לב רב-פרמטרים המשולב עם דפברילטור ידני ואק"ג, תרופות, מנשם אוטומטי, מכשיר עיסוי לב אוטומטי, אמצעים מתקדמים לניהול נתיב אוויר ועוד.

רכבי תגובה מיידית - אופנועים, אופניים וכלי רכב קטנים בעלי עבירות גבוהה, למשל בימבולנס ותומקאר. כלי רכב אלו משמשים את זרוע התגובה המיידית ומאפשרים לחובשים ופראמדיקים מתנדבים להגיע במהירות לאירועי חירום ולהעניק טיפול רפואי ראשוני טרם הגעת האמבולנס. נוסף על כך, העבירות של כלי הרכב האלה

מאפשרת פינוי מטופלים בשכונות שבהן יש סימטאות צרות, כמו אלו הנפוצות בירושלים.

קטנועים ואופנועים - גולת הכותרת של מערך המגיבים הראשונים המתנדבים היא יחידת האופנועים המתנדבים. בהצלת חיים כל דקה קובעת. במקרי חירום רפואיים יש צורך בהגעה מהירה מאוד - בטווח של דקות. זמני התגובה של ארגון רפואת חירום טרום-אשפוזית מושפעים מהיקף הפריסה של הצוותים ומעומס התנועה. בעשורים האחרונים עומס התנועה בישראל הולך וגדל, ועימו הצורך להרחיב את פריסת השירותים. התמודדות זו היא אכן נגף של כל שירותי רפואת החירום בעולם מאחר שהמשאבים המוגבלים אינם מצליחים להשיג את עומסי התנועה הגדלים והולכים.

מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, מפעיל משנת 2000 יחידה ארצית של אופנועים מתנדבים שתפקידה להגיע במהירות אל החולה או אל הנפגע ולהגיש לו עזרה ראשונה עוד בטרם הגעת האמבולנס. האופנועים מצוידים באמצעי החייה וציוד רפואי. יחידה זו, שמונה כיום למעלה מ-627 אופנועים, היא נדבך חיוני במערך הצלת החיים במדינת ישראל. מתנדב ביחידה זמין להזנקה 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, וקשוב לכל קריאת חירום המתקבלת במוקד מד"א ולגבי כל אירוע חירום שהתרחש בסמוך אליו.



תמונה 1.12 צי רכבי מד"א: אופנועים, אופניים ובימבולנס

כל קריאת חירום בטלפון 101 מוקלדת לתוך מערכת השליטה והבקרה. כבר במהלך השיחה, עם הזנת הפרטים הראשונים של כתובת האירוע ורמת הדחיפות, מאתרת המערכת את האופנועים הקרובים ביותר לאירוע ומעבירה להם באמצעים טכנולוגיים מתקדמים את פרטי האירוע. האופנועים מופיעים על מפת השליטה והבקרה, ומוקד הפעלה ייעודי מסייע למתנדב במהלך נסיעתו עד להגעה אל החולה. זמן ההגעה הממוצע הארצי (בעיר ובפריפריה) של האופנועים המתנדבים עומד על 4.5 דקות שהוא כמחצית זמן ההגעה של אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ בישראל.

בימבולנס (אמבולנס זעיר) - הוא כלי רכב חשמלי קומפקטי עם ציוד עזרה ראשונה והחייה מתקדם שמטרתו להגיע לאירוע חירום מייד ובלי עיכובים. בשל גודלו ניתן להגיע למקומות צפופים וצרים, מקומות שאליהם קשה להגיע עם אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ, וביכולתו להתגבר על עומסי תנועה. הבימבולנס נכנס לשירות במד"א ב־2018.

תומקאר (אמבולנס שטח) - הוא רכב שטח, בעל יכולת עבירות גבוהה. הוא מוצב בתחנות מד"א בחוף הים או בקרבת אתרי טבע שאינם נגישים לאמבולנסים רגילים. התומקאר נושא אלונקה אחת וצוות של שני אנשים.

אמבולנסים עם הנעה 4x4 - מאפשרים להגיע לטיפול בשטחים בעייתיים וקשים: בוץ, שלג ודרכים לא סלולות, גבעות וחולות. האמבולנסים האלה מצוידים באותו הציוד כמו אמבולנס רגיל.

רכבי הסופרווייזר - רכבי שטח המאפשרים לפראמדיקים המפקחים להגיע לכל אירוע, לסייע בטיפול, להציג תמונת מצב מלאה למוקדים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ואף לחלץ ולפנות נפגעים לפי הצורך. הרכב מצויד במוניטור דפירילטור, מערכת חמצן, ציוד החייה ומערכת תקשורת מתקדמת.

מסוקי טיפול נמרץ - למד"א שני מסוקים המאוישים על ידי טייס ושני פראמדיקים בכירים ותיקים שעוברים הכשרת

טיפול ופינוי בהיטס. המסוקים מופעלים בשיתוף חברת "להק", ומאפשרים לקצר את זמני הפינוי של מטופלים ונפגעים קשים ממקומות מרוחקים לבתי חולים ייעודיים. המסוקים מוצבים בשני מנחתים - בצפון ובדרום.



תמונה 1.13 מסוק מד"א

סירת היסבולנס - סירה שעוגנת בכנרת ומעניקה סיוע רפואי על החוף ובייחוד במים לטובעים ולנפגעים. הסירה מצוידת בצידוד רפואי מתקדם ומאוישת על ידי שלושה אנשי צוות: חובש, פראמדיק ומשיט.

אוטובוס, אמבולנס טיפול נמרץ - מגן דוד אדום, בסיוע של חיילי החטיבה הטכנולוגית ליבשה של צה"ל, פיתח אוטובוס ייעודי לפינוי חולים ופצועים רבים בבטיחות וביעילות. בכל אוטובוס ניתן לפנות עד שלושה עשר חולים ופצועים בבת אחת: שניים מהמפונים נמצאים בחלקו האמצעי של האוטובוס, הבנוי ברמה של ניידת טיפול נמרץ, ואחד עשר נוספים יושבים בחלק האחורי. במקרה הצורך האוטובוס יכול לשמש להסעה של עד ארבעה עשר חובשים ופראמדיקים לזירת אירוע מרוחק. האוטובוס מאפשר להעביר מטופלים רבים, ובכך מצמצמים באופן ניכר את מספר כלי הרכב המבצעיים הנדרשים לביצוע משימה של פינוי נפגעים רבים.



תמונה 1.14 סירת היסבולנס

סירת היסבולנס - סירה שעוגנת בכנרת ומעניקה סיוע רפואי על החוף ובייחוד במים. הסירה מצוידת בצידוד רפואי מתקדם ומאוישת על ידי שלושה אנשי צוות: חובש, פראמדיק ומשיט.

בכל אוטובוס מותקנות סירנות ומערכת תקשורת מתקדמת שמאפשרת ליצור קשר בין הצוותים שנמצאים בחלקים השונים של האוטובוס ובין מוקד מד"א. האוטובוס, שפותח על רקע התפרצות הנגיף קורונה בישראל, בנוי משלושה אגפים המאפשרים מניעת הדבקה בין המטופלים. אגף הטיפול הנמרץ כולל שתי מיטות מותאמות לחולים מורכבים מונשמים, ובהם כל המכשור המתקדם הדרוש, והאגף האחורי מאפשר מתן חמצן לכל מטופל, לפי הצורך.



תמונה 1.17 אוטובוס טיפול נמרץ

המחבורים למערכת מיוחדת שנמצאת בקדמת האוטובוס. באוטובוס יש שני מקרים המיועדים לאחסון מנות דם ותרופות שצריכות להיות בקירור. כמו כן האוטובוס מרושת בשקעי חשמל במתח 230V המאפשרים לחבר צידוד רפואי נוסף במידת הצורך, כגון אקמו ואינקובטור.



תמונה 1.15 חפ"ק מד"א



תמונה 1.16 רכב אר"ן



תמונה 1.18 אמבולנס המשאלות

רכב חפ"ק - יעילות הטיפול באירועים גדולים מותנית ביכולת שליטה ופיקוד. הדבר נכון בייחוד באירועים מתמשכים ומרובי נפגעים. לצורך שליטה באירועים מסוג זה יש ארבעה חפ"קים, רכבי חפ"ק מחוזיים הנמצאים בצפון, בדרום ושניים במרכז הארץ. כלי הרכב מאפשר להפעיל בוזמנית מוקד שליטה ובקרה, חדר דיונים ומוקד תקשורת. לרכב החפ"ק יכולות תקשורת המבוססות על מערכות סלולריות, יש לו יכולת צילום ושליטה מרחוק ויכולת לספק תשתית חשמל ותקשורת לצוותי מגן דוד אדום בכל רחבי המדינה.

רכבי אר"ן (אירוע רב־נפגעים) - רכב מבצעי שבו יש ערכות מתקדמות לעזרה ראשונה, ציוד רפואי, ציוד פינוי, עזרים לפיקוד ושליטה. זהו רכב שאין בו דבר מלבד ציוד. השימוש בו לפי התרחיש. יש אירועים רב־נפגעים שבהם אפשר לטפל במטופלים מייד, ולכן באירוע שכזה אנשי הצוות בזירה פורקים את הציוד הנדרש ובתום הטיפול נשלח כלי הרכב להצטייד מחדש כדי להיות מוכן לתרחיש הבא. נוסף על כך יש אירועים שבהם הנפגעים עדיין לא הגיעו (למשל בחילוץ ממושכים), בתרחישים כאלה פורסים את הציוד כאתר טיפול וכך נערכים מראש.

אמבולנס המשאלות - מד"א מפעיל את אמבולנס המשאלות, מיזם של מגן דוד אדום ששם לו למטרה למלא בקשות של אנשים המתמודדים עם מחלות קשות וסופניות. הגשמתה של כל משאלה מתוכננת בקפידה, בהתאמה מרבית לצרכיו וליכולותיו של המטופל ובליוי צוות רפואי שעבר הכשרה מתאימה. השירות ניתן ללא תשלום.

ניידת בנק דם - בנק הדם של מד"א מתרים מעל 300 אלף מנות דם בשנה. לשם כך, נוסף על מוקדי ההתרמה הקבועים בחלק מתחנות מד"א ובבנק הדם המרכזי בתל השומר, יש צי ניידות המשמשות להתרמות דם במפעלים, במוסדות, בצה"ל ובהתרמות דם יזומות בערים השונות, וכן רכבי שינוע שמטרתם להעביר את מנות הדם ואת מוצרי הדם מנקודות ההתרמה לבנק הדם וכן מבנק הדם לבתי החולים.

קודים מבצעים לכלי הרכב של מד"א

לכל כלי רכב יש קוד מבצעי המאפשר לזהות אותו, ועל פיו קוראים לרכב ברשת האלחוט. כמה מכלי הרכב של מד"א הם ממוגני ירי.

טבלה 1.1 טבלת הקודים המבצעים של מד"א

ניידות לטיפול נמרץ	11-500 (למעט 99, 100)
ניידות לטיפול נמרץ ממוגנות ירי	400-500
חפ"קים	550-580
מסוקים	591-595
אמבולנסים עם הנעה 4X4	600-699
אמבולנסים	600-2349 (למעט 700, 1000)
טיפול נמרץ צבאי	2350-2399
תחנות אירוע רב-נפגעים	2600-2649
טנדרים/ג'יפים ממוגני ירי	2650-2749
טרקטורון/ תומקאר	2750-2799
אמבולנסים ביישובים	3000-3400
אופנועים	5000-5999

הטכנולוגיות החדישות שבהן משתמשים במגן דוד אדום

בכל שנות קיומו של מד"א שאפו מנהליו ועובדיו לאמץ כל חידוש טכנולוגי שיש בו לתרום להצלחת חיים. לצורך זה הוקם במד"א צוות פיתוח שתפקידו לאתר טכנולוגיות חדשניות ולפתח רעיונות ופתרונות המיועדים לשיפור היכולות בכל תחומי הפעילות של הארגון, ולהתאים את הטכנולוגיות החדשניות לצרכים הייחודיים של מד"א ושל ישראל. ואכן, בזכות צוות הפיתוח שולבו במד"א אמצעים יעילים רבים המשפרים את היכולות הרפואיות והטכנולוגיות של הארגון.

המוקד הלאומי של מגן דוד אדום ניצב כיום בפסגת הטכנולוגיה ומשמש דוגמה ומודל לארגוני חירום רבים. המערכות הטכנולוגיות שלו משלבות יישומים מתקדמים, מחשבים המותאמים להפעלה בכלי רכב, טכנולוגיות איכון באמצעות איתור לווייני (GPS) ותקשורת נתונים סלולרית (CDPD). שילוב כל אלה מאפשר לאתר מייד ובמדויק כל אחד מהאמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ ברחבי הארץ בכל רגע נתון. נוסף על כך מאפשרת המערכת לקבל תמונת מצב מלאה מכל זירת אירוע ולהזניק צוותים במהירות וביעילות כדי להעניק טיפול מידי לכל נפגע ובכל מקום. המערכת אף מאפשרת למסור לצוות פרטים על הנפגע, לשוחח עם משפחתו ואפילו לראות תמונות ראשונות מזירת האירוע בזמן שהאמבולנס נמצא בדרכו.

כל שיחה המגיעה למוקד 101 מוקלדת במערכת הממוחשבת ומדווחת מייד למוקדן משגר האמבולנסים, למוקד הכוננים ולמוקד הארצי, ואלו דואגים להזניק את הצוות הזמין ביותר אל המטופל. הם עוקבים אחר הטיפול בו עד שהוא מגיע לבית חולים. כל תהליך ההזנקה מתרחש בתוך שניות מעטות. את הפעילות בשטח מלווה

מערכת הקלטה רב־ערוצית. מערכת זו מאפשרת לבצע תחקירים ולהפיק לקחים עוד בטרם הסתיים האירוע.

כשמתקבלת שיחה מאדם שאינו יודע לומר היכן בדיוק מתרחש האירוע, תורן המוקד יכול לאתר אותו באמצעות הטלפון הנייד שממנו באה הקריאה. לשם כך המתקשר מתבקש להפעיל את ה־GPS במכשיר הטלפון הנייד שלו ואז נשלח אליו מסרון (sms), עם קישור ליישום המאפשר לאתר את מקומו. נתוני היישום מועברים מייד למערכת השליטה והבקרה, וזו משדרת את המקום המדויק לאמבולנס שכבר יצא לשטח, עם הנחיות מדויקות.

באפריל 2018 נכנסה לפעולה מערכת לשיבוץ אוטומטי. המערכת מאתרת את האמבולנס הקרוב ביותר למקום האירוע ומשבצת לו את המקרה לפי חומרת האירוע כפי שנקבעה על ידי המוקדן. עם זאת, על פי שיקול דעת מקצועי, למשגר יש סמכות לשנות את השיבוץ שבחרה המערכת האוטומטית.

בד בבד עם ההזנקה והשיגור, המוקד משדר למזעיק כמה כללים לטיפול מיידי בנפגע כדי לייצב את מצבו. מייד עם הפניית אמבולנס אל הנפגע מתחברת המערכת לתוכנת ניווט המכוונת את נהג האמבולנס בעזרת מפה אל המקום המדויק שאליו עליו להגיע. נתונים אלה מועברים אוטומטית גם לכל הכוננים היוצאים אל המקום ברכבם הפרטי.

לאחר הטיפול בנפגע ממלא איש מצוות האמבולנס דוח רפואי ממוחשב הנשלח לבית החולים עוד לפני שהנפגע הגיע אליו. כך יכול בית החולים להיות מוכן מראש לקבלת המטופל. לתיאום זה תפקיד חשוב בהצלחת חיים, בשיפור סיכויי ההחלמה וההישרדות ובהקטנת סיכוני הנכות. דוח זה נשלח בזמנית גם אל המוקד ששיגר את האמבולנס ולמוקד הרפואי.

לדוגמה, במקרים של אוטם שריר הלב, המערכת מאפשרת להעביר למחלקה הקרדיולוגית בבית החולים את תרשים האק"ג של המטופל, ולאחר התייעצות של הפראמדיק באמבולנס עם בית החולים אפשר להעביר את המטופל ישירות לחדר הצנתורים בלי להתעכב בחדר המיון כלל. כך נחסך זמן יקר, ובזכות הצנתור המהיר נמנעת פגיעה בלתי הפיכה בשריר הלב.



תמונה 1.19. יישומון מד"א שלי

החדשנות במד"א מתבטאת גם בהפעלת יישומונים (אפליקציות) המותקנים בטלפונים חכמים. אחד החשובים שבהם הוא "מד"א שלי" - יישומון חינוכי להגשת עזרה ראשונה שפותח על ידי הצלב האדום האמריקאי, הותאם לשימוש מלא בישראל, הושק בארץ ב־2013 והוכר כיישום רשמי של מד"א. היישום מאפשר למשתמש ללמוד לזהות מצב חירום רפואי ולהגיש סיוע ראשוני.

עוד ביישומון שפותח על ידי מד"א מאפשר להעלות נתונים רפואיים של המטופל כולל סיכומי מחלה, תרשים אק"ג, אלרגיות, נשיאת אפיון או משאף ונטולין, ציון בנגוע

למושתלי קוצב או חולי סוכרת ועוד. בעת הצורך אפשר להתקשר למוקד החירום דרך היישומון המאפשר גם לשדר מייד את מקום המתקשר אל תוכנת השליטה והבקרה במוקד, לנהל שיחות וידאו מתקדמות ועוד. אחד מיתרונות היישום הוא שלאחר הורדתו הראשונית והתקנתו הוא זמין גם במקומות שבהם אין חיבור לאינטרנט. באמצעות היישומון אפשר להעביר מידע מהיר ואמין אל שירותי רפואת החירום, ובכך לקצר את זמן המענה ולייעל את הטיפול.

יישומון חשוב אחר המיועד לקצר למינימום את פרק הזמן העובר בין קריאה לעזרה ובין התחלת הטיפול בנפגע, הוא יישומון "צוותי מגן דוד אדום" המאתר את כונני מד"א או את המתנדבים הקרובים ביותר למקום האירוע, ובאמצעות הטלפון החכם שברשותם מזניק אותם אל הנפגע. היישומון מנווט את המתנדב דרך תוכנת הניווט המועדפת שלו, והיא מנווטת את הצוות או המתנדב בדרך הקצרה והבטוחה ביותר אל המטופל. יישומון חיוני זה מאפשר למערכת השליטה והבקרה להזניק את הכוננים והצוותים הסמוכים ביותר אל מקום האירוע. היישומון מאפשר לכל מי שמוכשר בעזרה ראשונה, גם אם אינו נמנה עם צוות מד"א, להצטרף למד"א כמתנדב אד-הוק.

נוסף על מערכות המחשב שהותקנו באמבולנסים בשנים האחרונות הותקנו מצלמות המשקיפות דרך השמשה הקדמית של האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ, סורקות את השטח שלפניהם ומשדרות את התצלומים בזמן אמת אל המוקד. הדבר מאפשר לאנשי המוקד לראות במו עיניהם את המתרחש בשטח האירוע שבו פועל האמבולנס או ה"נט". עוד מצלמה מותקנת בתוך האמבולנס, ואם החובשים או הפראמדיקים זקוקים לייעוץ רפואי, היא משדרת אל המוקד הרפואי צילום בזמן אמת של הנפגע. בדרך זאת יכול הרופא במוקד המרוחק להשתתף בטיפול.

רכבי הסופרובייזר של מד"א מצוידים גם הם במצלמה המותקנת על ראשו של תורן מתקפל. מתקן זה הוכיח את חשיבותו באסון רכבת שאירע ליד חדרה. באירוע זה הגיעו צוותי ההצלה לצד אחד של פסי הרכבת שבו רוכזו הנפגעים שנמצאו באותו צד. אלא שהמסילה במקום זה עוברת על סוללה גבוהה, והיא מנעה מצוותי ההצלה לראות אם יש נפגעים גם בצידה השני. רכב סופרובייזר שהגיע למקום העלה את תורן המצלמה וגילה מייד כי אומנם יש נפגעים מעבר למסילה וכך יכלו גם הם לקבל טיפול הולם.



תמונה 1.20 צוותי מד"א מטפלים בנפגעי תאונת דרכים

האירועים שבהם מטפל מגן דוד אדום

בימי שגרה רוב המקרים שבהם מטפלים צוותי מד"א הם מקרי מחלה; כ-65% מהמטופלים הם מבוגרים בני 18 ומעלה, ו-5% הם ילדים - אלו מזעיקים את מד"א לטיפול במחלות ופגיעות. תאונות דרכים הן כ-8% מעבודת מד"א, ופציעות אחרות הן כ-16%, לידות ופינוי יולדות הם כ-2%, מקרי שריפה כ-1% והשאר כ-3%.